

양방진단학 SUMMARY 공지사항

- 내년에 하게 될 CPX 실습의 중요성에 대한 내용이라 시험에 나올지는 모르겠습니다. 한번 읽어보시는 것을 추천드립니다.

양방진단학 SUMMARY 사용법

- 중요해 보이는 내용은 가독성을 위해 **굵은 글씨**와 **빨간 글씨**, **파란 글씨**로 표시하겠습니다.

CPX/ OSCE 수업에서 선생님들이 얻어갔으면 하는 것들

- CPX 가 뭐고 어떻게 준비하고 준비할 때 염두해야 될 것에 대해 설명할 예정
- 이번 국시가 1 월 17 일이고, 우리 실습 전에 한번 다 같이 모일 예정이라 실습 직전에 시행할 예정이다.(1 월 16 일 예상)
- 와플에 들어가면 자료실에 자료 다 있으니까 실습 전에 보고 싶으면 보라

1/2 학기 임상술기실습 성적 산출 방법

- 1 학기/2 학기 배정 비율은 알려주지 않음
- 출석, 태도
OSCE 키트 및 준비 점수에서 감점
- 익산 OSCE 10 개
- CPX 역할극 발표자료 및 역할극, 태도
- CPX 9 주차 개인별 전체 동영상
다른 조에서 한걸로 해야 함 우리조에서 준비한 것 말고
- 포트폴리오
구글 클래스룸 확인
- 2 학기 성적에만 반영
2 학기 임상종합 평가 (1 학기 OSCE 2 개 뽑아서 10 월-11 월 중 시험)
2 학기 졸업고사

본 4 임상술기실습 CPX/ OSCE 관련 수업 방식

- 익산 (임상술기실습 성적에 반영)
 - 목요일 오전 9:00-11:00 CPX 역할극 (의사/환자 시나리오 직접 작성 후 역할극)
 - 목요일 오후 (상세시간 추후 공지) : OSCE 10 개
1. 초음파 2. 12 뇌신경 검사 3. 창상드레싱 4. 도뇨관삽입 5. 비위관삽입 6. 호침 7. 약침 8. 물리요법 9. 추나 10. BPPV 진단 및 수기법
2025 년 추가 예정 : 채혈 / + 심전도 및 심폐소생술?
- 광주/전주 CPX 총 10 개 (해당과 성적에 반영)
 - 시나리오는 따로 만들지 않음. 정해진 증상의 표준화 환자(레지던트)에 대한 병력청취, 이학적 검진을 통해 추정진단을 하고 환자에 대한 교육을 통해 의사환자관계에 대해서 평가

CPX 목표

학교를 다니면서 진단과정을 어떻게 해야 되는지 실제로 배우고, 실습을 해본 적이 별로 없기에

- 졸업 전에 진단 과정을 익혀보기
- 전공의 과정이나 로컬에서 진료를 할 때 부족함을 많이 느낌.
- 전공의 때의 증례 컨퍼런스 경험 - 편두통
- 군발성 두통 호전 사례

6년간 파편적으로 배웠던 다양한 과목의 지식들이 하나로 엮어지면서, 왜 진료의 끝이자 출발로서의 진단이 중요한지?

-> **망문문절과 이학적/신경학적 검진과 병력청취를 통해 가능성이 높은 추정진단을 제시하고, 확진에 필요한 추가검사를 제시하고, 치료법을 선정하여 치료목표를 설명해주고, 관리 방법과 예후에 대해 설명을 하는 과정 (=진료)이란 무엇인지?**에 대해서 이해해 나가는 과정

1) 병력청취와 이학적 검진 2) 을 통한 진단적 추론과 3) 의사-환자 관계 4) 그 과정에 필요한 OSCE

CPX(Clinical Performance Examination) 과 OSCE(Objective Structured Clinical Examination)

- 학부과정에서는 질환을 중심으로 수업이 이루어짐
 - 하지만, 실제 진료에서는 ~~ 증상을 호소하는 환자가 내원함
해당 증상을 바탕으로
병력청취 및 이학적 검진/신경학적 검진을 통해서
추정진단을 내리고
그에 맞는 치료계획과 교육을 세우는 것이 진료의 과정
 - 위의 과정에 대해서 CPX 를 통해서 실습평가하고, CPX 사이에 필요한
검진, 술기 등에 대해서 OSCE 를 통해서 평가
- 추가로 2023 년과 다르게 혈액검사(간기능, 신기능, 전해질 등), 영상검사(심전도, 초음파, 엑스레이 등)의 결과도 활용할 수 있어야 함
- 우리는 질환을 중심으로 배우는데, 실제 환자는 한의원에 오면 손이 떨린다든지 심장이 두근거린다든지와 같은 증상으로 오기 때문에 증상을 바탕으로 병력청취 및 이학적 검진, 신경학적 검진을 통해서 추정진단을 내리고 그에 맞는 치료계획과 교육을 세우는 것이 진료의 과정이다.

사담

- 요즘은 교수님들 따라 다니면서 환자들 보고 하는 거는 감염 문제 때문에 제대로 하지 못한다.
- 의산에서는 CPX 시나리오를 직접 만드는 것을 해볼 것이고, 광주, 전주에서는 시나리오는 만들지 않지만 질환을 맞추는 연습을 할 것이다.
- 진단에 있어서 제대로 질환을 감별해야지 증례를 쓰고, 기록을 할 수 있는 것인데 그렇지 않은 한의사가 많다.(진단이 틀리면 환자가 나아도 의미가 없다)
- 진단은 자신이 아는 지식을 바탕으로 가장 확신할 수 있는 질환을 선별하는 과정으로 환자에게 해당 과정과 그 근거, 치료 계획을 잘 설명해야 한다.(+예후 설명과 관리 방법)
- CPX 를 통해서 진단을 하는 연습을 하고 졸업하기를 바란다.

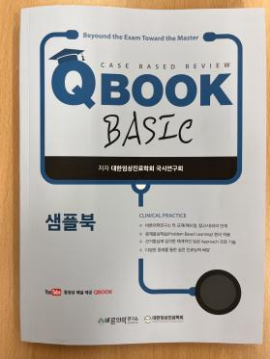
Disease Illness Script

- 수평적읽기 대비 자료가 다 만들어진 후에 최종적으로 Dz illness script 만들 것.
(따라서, 당연히, 제출은 의사조 메인 자료보다 늦게 내도 됩니다)
 - 서식은 한글로 만들어서 엑셀파일로 구글클래스룸에 공유됨
- 초보 의사들은 수평적 읽기 방식으로 질환의 메커니즘, 경과, 증상, 징후, 감별진단, 검사, 치료, 예후에 대해 단편적인 단순암기를 한다. 하지만 우리는 이것을 통해 하나의 질환을 확정하는 것이 목적이 아닌 다른 질환과의 비교가 필요하다.(환자의 호소 형태에 따라 정리해야 함)
- 질환들에 대해 메커니즘, 증상, 역학적 특성 등을 수직적으로 비교할 수 있어야 하며, 이때 유용한 도구가 disease illness script 이다.
- 간단히 설명하면 우리 맨날 심계 시험 때 보는 질환 비교를 표로 만들어 놓은 거 같음.

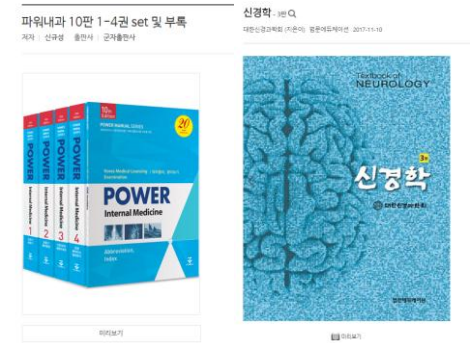
Table 4.5 Contrasting competing illness scripts

Example of a problem representation			
A middle-aged female with a chronic, gradually progressive symmetrical oligoarticular process involving small joints characterized by moderate to severe morning stiffness			
Exemplar diagnosis	1- Osteoarthritis	2- Rheumatoid arthritis	
Enabling conditions	Age, sex, race, ethnicity	Over 50 yrs.; either sex	30-60 years, F:M ratio 3:1
	Family history, genetics	+/- family history	+ family history; shared epitope, HLA-DRB1
	Habits, exposures, medications	None	Smoking
	Nested comorbidities	None	Coronary artery disease
Pathophysiological fault		Mechanical, degenerative; cartilage breakdown and subsequent bone hypertrophy	Inflammatory, immunologic; synovitis, pannus and subsequent erosion of juxta-articular bone
Clinical consequences	Onset	Gradual	Gradual
	Site	Small, large joints; appendicular; polyarticular; involves DIP	Small, large joints; appendicular; polyarticular; usually spares DIP
	Severity	Mild	Moderate
	Chronology	Chronic persistent	Chronic persistent
	Exam findings	Bony enlargement of joint; mild tenderness if any	Warmth; erythema; tenderness; swelling; occasional rheumatoid nodules
	Laboratory findings	None	Elevated ESR; rheumatoid factor anti-CCP
	Imaging findings	Sclerosis of bone under cartilage; joint space narrowing; osteophytes	Erosive polyarthritis; joint space narrowing

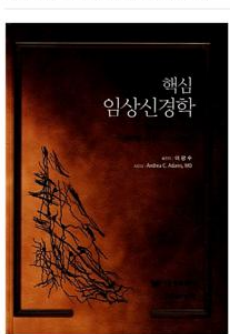
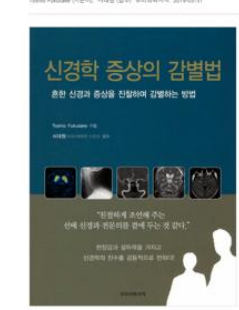
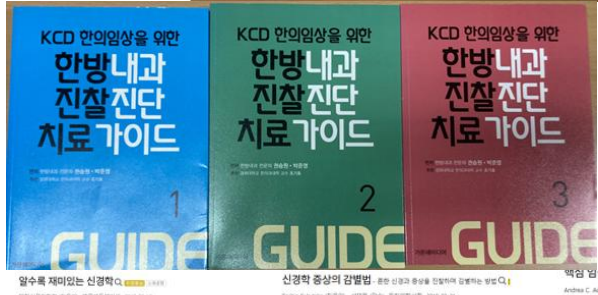
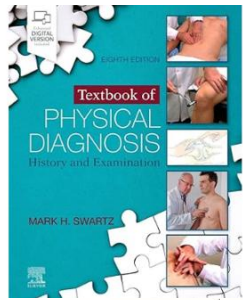
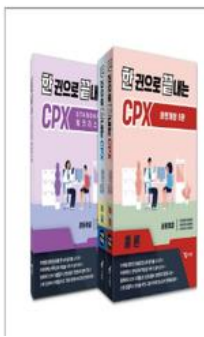
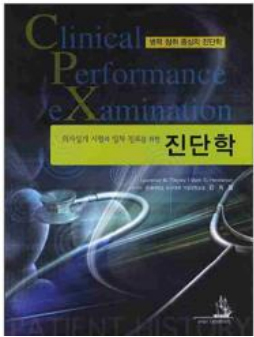
본 4 CPX 기본 교재



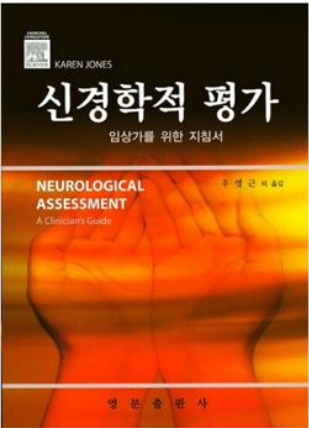
- 의대 교과서, 국시 교재(아래)



- 참고할만한 책



신경학적 평가Q 김동웅 신경학
우영근 (지은이) | 영문출판사 | 2015-08-26



(절판)

알기쉬운 신경학 검진법 - 4판 Q 김동웅 신경학
Geraint Fuller (지은이) | 박경석 (옮긴이) | 엘스비어코리아(Elsevier) |

